

Intérêt de l’ADN tumoral circulant dans le suivi et la détection précoce des récidives du cancer colorectal localisé : revue de la littérature.

Briguen Amel
Oncologue médical - EPH El Eulma

Introduction

Le pronostic du cancer colorectal (CCR) localisé repose sur la classification TNM, parfois insuffisante pour prédire les récidives. L'évaluation de la maladie résiduelle minimale (MRM) par l'ADN tumoral circulant (ADNtc) émerge comme un biomarqueur moléculaire clé. Cette revue évalue son impact dans la stratification pronostique, le guidage thérapeutique et la détection précoce des récurrences.



Méthodes

Recherche systématique de la littérature

- PubMed, Embase
- Congrès de l'ASCO/ESMO jusqu'en 2026.

Critères d'inclusion

- Essais prospectifs et cohortes majeures (DYNAMIC, CIRCULATE-Japan) évaluant l'ADNtc après résection curative de CCR de stades II/III.

Principales études incluses

DYNAMIC

Stratégie guidée par l’ADNtc en stade II.

CIRCULATE -Japan

l’ADNtc et ajustement thérapeutique .

Résultats

1 DYNAMIC stade II

Chimiothérapie adjuvante ADNtc -	VS	Standard
15%		28%

Survie sans récidive à 2 ans ADNtc	VS	Standard
15%		28%

La stratégie guidée par l’ADNtc n’est pas inférieure au standard sur le plan de survie

2

CIRCULATE -Japan

ADN tc postopératoire positif fortement associé au risque de récidive,

HR =10,8
pour le stade II et /III .

Stratification pronostique précoce

- Détection de la maladie résiduelle minimile avant la récidive clinique .
- Permet un ajustement thérapeutique plus précoce et personnalisé .

✓ Point forts :

Approche non invasive.
Haute spécificité et sensibilité .

Discussion

L'ADNtc fait passer la prise en charge du CCR d'un modèle morphologique statique à un suivi moléculaire dynamique. Il valide la désescalade thérapeutique chez les patients à bas risque et sécurise l'escalade précoce pour les profils agressifs. Malgré des défis techniques (hétérogénéité du relargage selon les sites métastatiques, choix des plateformes tumor-informed), son intégration dans les recommandations cliniques s'impose pour guider l'oncologie de précision ,

Conclusion

L’ADN tumoral circulant constitue un biomarqueur prometteur pour la détection précoce des récidives et la stratification du cancers colorectal localisé. Les études DYNAMIC et CIRCULATE –Japan confirme son intérêt et ouvre la voie à une prise en charge plus personnalisée,

Mots clés

Cancer colorectal ; ADN tumoral circulant ; Maladie résiduelle minimale ; Chimiothérapie adjuvante ; Récidive.